Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология 2

2.3 Локализация 2

2.4 Клиническая картина 3

2.5 Жалобы и анамнез 3

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр и фарингоскопия 4

3.2 Ларингоскопия 4

3.3 КТ и УЗИ шеи 4

3.4 Анализы крови и мочи, посев 5

3.5 Дифференциальная диагностика 5

4. Лечение 5

4.1 Хирургическое лечение 5

4.2 Антибактериальная терапия 6

4.3 Дополнительная терапия 7

4.4 Послеоперационное ведение 7

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения 7

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Лечение в стационаре у оториноларинголога; основной метод: хирургическое вскрытие абсцесса.
- Передневерхний абсцесс: более 70% случаев, между капсулой нёбной миндалины и верхней частью передней нёбной дужки.
- Антибиотики широкого спектра, активные в отношении анаэробов, эмпирически, до результатов посева; курс **10–14 дней**.
- Абсцесстонзиллэктомия (миндалины удаляют одновременно со вскрытием):
  1. частые ангины в анамнезе;
  2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
  3. затяжное течение;
  4. неадекватное дренирование;
  5. кровотечение после вскрытия.
- Если выполнено только вскрытие: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс характеризуется гнойным расплавлением паратонзиллярной клетчатки, расположенной между псевдокапсулой нёбной миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Этиология

Пути инфицирования

1. осложнение ангины (большинство случаев);
2. хронический тонзиллит;
3. одонтогенный: кариес задних зубов нижней челюсти (вторые моляры, зубы мудрости), периостит альвеолярного отростка;
4. инородное тело в паратонзиллярной клетчатке (например, рыбная кость).

Наиболее частыми возбудителями являются бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы.

На момент обращения отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная форма выявляется у 15–20% пациентов, абсцедирующая форма у 80–85%. Абсцесс формируется, как правило, через 4–6 дней от начала заболевания, в ряде случаев в течение нескольких часов.

2.3 Локализация

1. передневерхний (супратонзиллярный): более 70%; между капсулой миндалины и верхней частью передней нёбной дужки;
2. задний: около 15%; между миндалиной и задней нёбной дужкой;
3. нижний: несколько более 5%; между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки;
4. боковой: менее 5%; между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс развивается, как правило, на фоне ангины или через несколько дней после неё.

1. боль при глотании, становится постоянной, резко усиливается при глотании слюны, иррадиирует в ухо и зубы;
2. головная боль, разбитость, лихорадка до фебрильных значений;
3. отказ от пищи и питья;
4. нарастающий тризм жевательной мускулатуры;
5. невнятная, гнусавая речь;
6. вынужденное положение головы набок, поворот всем корпусом.

Передневерхний абсцесс:

1. резкое выбухание верхнего полюса миндалины вместе с нёбными дужками и мягким нёбом к средней линии;
2. язычок смещён в противоположную сторону;
3. миндалина оттеснена книзу и кзади.

Задний абсцесс:

1. припухлость в области задней нёбной дужки, возможен переход на боковую стенку глотки;
2. миндалина и передняя дужка изменены незначительно;
3. отёк язычка и мягкого нёба.

Нижний абсцесс:

1. при фарингоскопии лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки при выраженных жалобах;
2. возможно вовлечение корня языка, отёк язычной поверхности надгортанника;
3. распространение отёка на гортань может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс: встречается реже других, но протекает тяжелее всех (условия для самопроизвольного прорыва гноя в глотку наименее благоприятны).

1. отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения;
2. кривошея;
3. тризм;
4. при фарингоскопии лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. недавно перенесённые ангины;
2. хронический тонзиллит;
3. паратонзиллиты и абсцессы в прошлом и их лечение;
4. кариес;
5. возможное попадание инородного тела (рыбная кость).

Местные жалобы

1. выраженная, как правило односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании, с иррадиацией в ухо и зубы;
2. ощущение инородного тела;
3. гнусавость;
4. неприятный запах изо рта;
5. боль в шее при поворотах головы;
6. тризм;
7. слюнотечение.

Общие жалобы (неспецифичны)

1. слабость, разбитость;
2. фебрильная лихорадка;
3. головная боль.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза;
2. физикального обследования с оценкой подчелюстной области и регионарных лимфатических узлов;
3. фарингоскопии;
4. лабораторных исследований.

3.1 Осмотр и фарингоскопия

Показания

1. каждый пациент с подозрением на паратонзиллярный абсцесс: осмотр оториноларинголога.

Диагностические признаки (наиболее выражены при переднем абсцессе)

1. яркая гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка;
2. асимметрия мягкого нёба;
3. смещение миндалины;
4. ограничение открывания рта;
5. регионарный лимфаденит.

Показания

1. все дети и взрослые; данные фарингоскопии решающие для диагноза.

3.2 Ларингоскопия

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на гортаноглотку: непрямая ларингоскопия или фиброларингоскопия.

3.3 КТ и УЗИ шеи

Показания к КТ и УЗИ шеи

1. тяжёлые случаи: уточнение диагноза и локализации абсцесса;
2. дифференциальная диагностика с воспалением глубоких отделов шеи.

3.4 Анализы крови и мочи, посев

Показания

1. все пациенты: развёрнутый общий анализ крови, С-реактивный белок (СРБ), общий анализ мочи.

Диагностические признаки

1. выраженный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и высокий СРБ: высокий риск осложнений, нужна коррекция лечения, в том числе антибактериальной терапии.

Показания

1. гнойное отделяемое после вскрытия: посев на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности;
2. мазок с миндалин на палочку дифтерии: исключение дифтерии.

Для исследования предпочтительно брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости, поскольку ферменты гноя разрушают микроорганизмы. Материал доставляется в лабораторию в транспортной среде, оптимально в течение 40 минут.

3.5 Дифференциальная диагностика

Дифференцируют с

1. дифтерией;
2. скарлатиной;
3. абсцессом язычной миндалины;
4. абсцессами подъязычной области;
5. флегмоной дна полости рта;
6. опухолями ротоглотки;
7. перикоронитом.

Дифтерия: слизистая бледная, с цианотичным оттенком; налёты сероватые, выходят за пределы миндалин; тризма нет.

1. скарлатина: сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой, «малиновый» язык;
2. абсцесс язычной миндалины: нет тризма и типичных изменений в ротоглотке;
3. флегмона дна полости рта: боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, дужки и миндалины не изменены.

Опухоль миндалины: медленное развитие, нет лихорадки, выраженной боли и тризма; регионарные лимфатические узлы плотные, малоболезненные, малоподвижные.

В редких случаях припухлость в глотке обусловлена близким к поверхности расположением сонной артерии или её аневризмой; на это указывает визуально определяемая пульсация.

---

4. Лечение

Лечение осуществляет оториноларинголог в специализированном учреждении; основным методом лечения является хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс: вскрытие и дренирование.

Правила (при любой технике)

1. убедиться в отсутствии пульсации в месте разреза;
2. глубже **0,5 см** продвигаться только тупым путём;
3. разрез достаточно широкий, **до 4 см**.

Местная аппликационная анестезия; место разреза по локализации:

1. передневерхний: через переднюю нёбную дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания;
2. задний: через заднюю дужку, отступив 0,5 см от её края;
3. нижний: в нижней части передней дужки.

Ткани рассекают вдоль хода сосудов на глубину 0,5–1 см, далее разводят корнцангом.

В последующем края разреза регулярно разводятся до начала заживления полости.

Абсцесстонзиллэктомия (удаление нёбных миндалин одновременно со вскрытием) устраняет и сам очаг инфекции. Показания:

1. частые ангины в анамнезе;
2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
3. затяжное течение;
4. неадекватное дренирование;
5. кровотечение после вскрытия.

Возраст: от 3–4 до 70 лет и старше.

Противопоказания

1. терминальное или крайне тяжёлое состояние вследствие заболеваний внутренних органов;
2. тромбоз сосудов мозга;
3. разлитой менингит.

После операции осматривают тонзиллярную нишу; выбухание в ней свидетельствует о парафарингеальном абсцессе.

4.2 Антибактериальная терапия

Системную антибактериальную терапию начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева. Поскольку в полости абсцесса, как правило, присутствуют анаэробы, необходимы препараты широкого спектра действия, активные и в отношении анаэробной микрофлоры.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или при массе тела от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Возможно применение #амоксициллина с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице рекомендации указана как «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не более 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не более 50 мг/кг в сутки.
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс **10–14 дней**.

1. препараты выбора: пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз;
2. затруднённое глотание: диспергируемые формы, суспензии, инъекции;
3. выраженный отёк тканей глотки и шеи, выраженный тризм, высокий риск генерализации: парентеральные цефалоспорины III поколения, при непереносимости клиндамицин;
4. дети: предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой.

4.3 Дополнительная терапия

При выраженных воспалительных проявлениях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в стандартных дозах.

Всем пациентам рекомендованы антигистаминные препараты системного действия.

Рекомендацией предусмотрено также применение средств, повышающих естественную резистентность организма (препараты кальция, витамины С и А); при этом следует избегать полипрагмазии.

При выраженной интоксикации необходима инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Всем пациентам рекомендованы также местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства (полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания), однако они не заменяют системную антибактериальную терапию.

После хирургического лечения, не ранее чем через 3 недели после купирования острого воспаления, показана консультация физиотерапевта.

4.4 Послеоперационное ведение

После вскрытия абсцесса: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

После тонзиллэктомии ограничение физической нагрузки **в течение месяца**.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения

1. при диспансеризации выявляют факторы риска: хронический тонзиллит, рецидивирующие ангины;
2. закаливание;
3. своевременное лечение заболеваний зубов и дёсен.

Лечение в хирургическом стационаре.

Показания к госпитализации

1. вскрытие абсцесса;
2. удаление нёбных миндалин со вскрытием абсцесса.

После вскрытия улучшение **через 12–24 часа**; при неосложнённом течении после абсцесстонзиллэктомии выписка **на 5–7-е сутки**.

Осложнения при отсутствии или неадекватности лечения

1. флегмона шеи;
2. медиастинит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. инфекционно-токсический шок.

Риск выше при иммунодефиците: врождённом, на фоне иммуносупрессоров и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефтриаксона в таблице 1 указано «в течение 4-14 дней до 10 дней», что содержит противоречие в сроках; на странице формулировка приведена дословно.